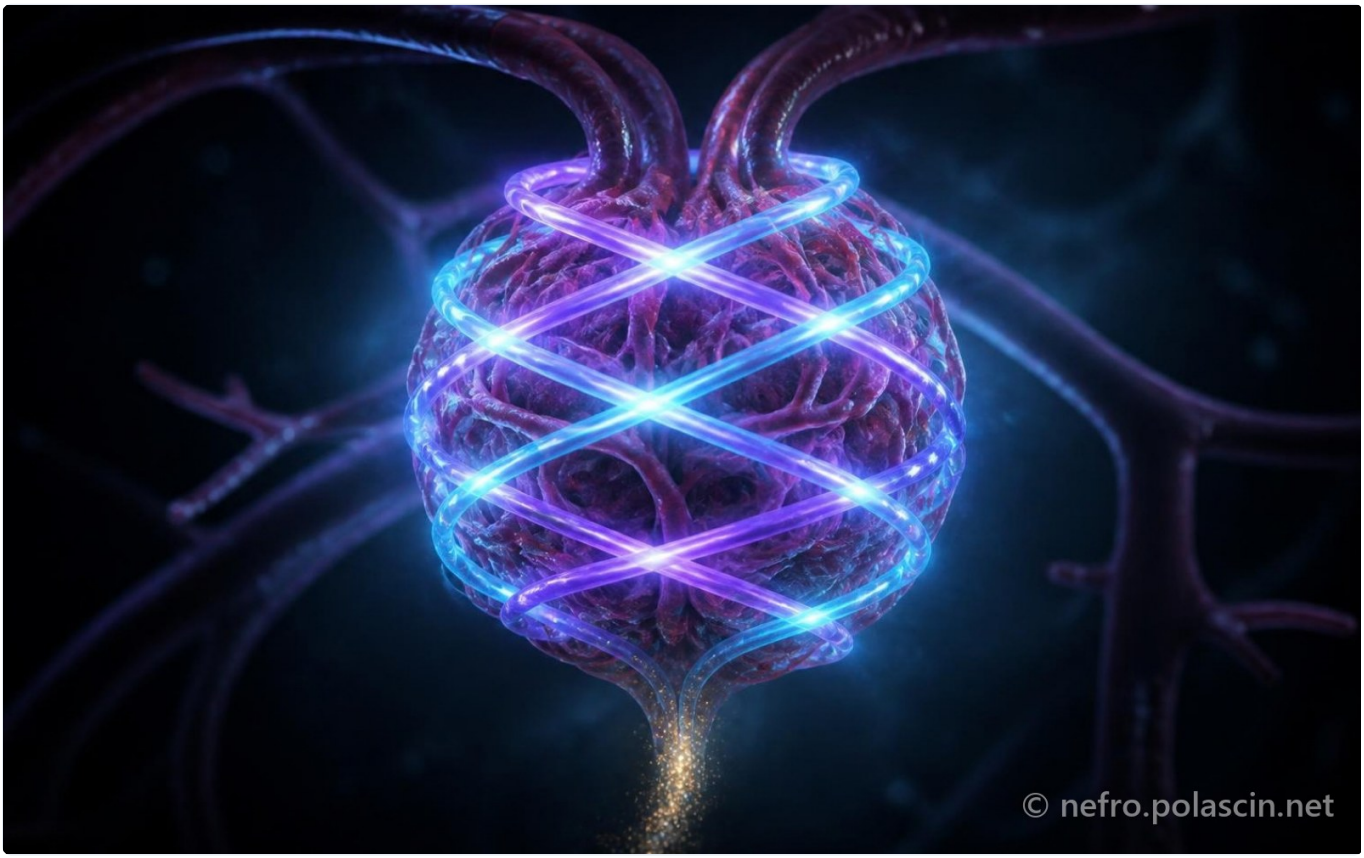
Sparsentan s inhibítorom SGLT2 pri IgA nefropatii: SPARTACUS a PROTECT OLE

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 14.09.2026



Poloschematická vizualizácia. Dva mechanizmy sa tu nenahrádzajú, ale vrstvia; otázkou pre prax je, koľko navyše prinesie druhá vrstva.

Sparsentan (duálny antagonista endotelínového a angiotenzínového receptora, DEARA) a **inhibítory sodíkovo-glukózového kotransportéra 2 (SGLT2i)** znižujú proteinúriu pri IgA nefropatii (IgAN). V *Nephrology Dialysis Transplantation* (2026) Ayoub a kol. zhrnuli účinnosť a bezpečnosť ich kombinácie v dvoch komplementárnych nastaveniach: v otvorenej štúdii fázy 2 **SPARTACUS** a v randomizovanej substúdii otvoreného predĺženia (OLE) štúdie **PROTECT**. Text vychádza z abstraktu publikácie, preto ho treba čítať opatrne, najmä pri extrapolácii na tvrdé obličkové alebo kardiovaskulárne ukazovatele.

Hlavné zistenia

- V **SPARTACUS** (NCT05856760) sa u pacientov so stabilným SGLT2i vymenil inhibítor systému renín–angiotenzín (RASi) za sparsentan. Do 24. týždňa klesol pomer albumínu ku kreatinínu v moči (UACR) o LS mean **−56 %** (95 % interval spoľahlivosti [IS] −66 % až −3 %).
- V substúdii **PROTECT OLE** (NCT03762850) pridanie SGLT2i k stabilnému sparsentanu v 12. týždni prinieslo relatívne priaznivejšiu zmenu pomeru proteínu ku kreatinínu v moči (UPCR) oproti samotnému sparsentanu (pomer 0,75; 95 % IS 0,58–0,98; $P < 0,05$).
- Kombinácia bola podľa abstraktu **dobre tolerovaná**; závažné alebo vážne nežiaduce udalosti súvisiace s liečbou boli zriedkavé a neočakávané bezpečnostné signály sa nehlásili.
- Ide o **náhradné (surogátne) ukazovatele** (UACR/UPCR) a relatívne krátke sledovanie. Samostatný dôkaz o spomalení poklesu eGFR, zlyhaní obličiek či kardiovaskulárnych príhodách z týchto dát nevyplýva.

Prečo má kombinácia DEARA + SGLT2i zmysel

Sparsentan blokuje endotelínový receptor typu A a receptor angiotenzínu II typu 1. Inhibítory SGLT2 pôsobia cez tubuloglomerulárnu spätnú väzbu, znižujú intraglomerulárny tlak a majú ďalšie systémové účinky. Pri IgAN sa obe cesty používajú ako neimunosupresívna nefroprotekcia; otázka **sekvencie a súčtu účinkov** (výmena RASi za sparsentan pri už užívanom SGLT2i vs. pridanie SGLT2i k sparsentanu) však pre bežnú prax zatiaľ nie je dostatočne zodpovedaná.

SPARTACUS a PROTECT OLE sa venujú práve týmto dvom situáciám. Nie sú to však veľké štúdie s tvrdými klinickými ukazovateľmi ani priame porovnanie s inými modernými režimami (napr. cieľová imunomodulácia podľa KDIGO).

SPARTACUS: výmena RASi za sparsentan pri stabilnom SGLT2i

SPARTACUS bola **fáza 2, otvorená** štúdia. Pacientom bol RASi nahradený sparsentanom a pokračovali v stabilnej liečbe SGLT2i. Zaradených bolo **48** pacientov (priemerný vek 48,9 roka, SD 13,9; 58 % mužov); liečbu dokončilo **39**.

Výmena RASi za sparsentan viedla k **rýchlemu a do 24. týždňa udržanému poklesu UACR**: LS mean −56 % (95 % IS −66 % až −3 %). Interval spoľahlivosti uvedený v abstrakte je výrazne asymetrický; bodový odhad však naznačuje klinicky relevantnú redukciu albuminúrie.

Položka	Údaj (abstrakt)
Dizajn	Fáza 2, otvorená; NCT05856760
Intervencia	Výmena RASi → sparsentan pri pokračujúcom stabilnom SGLT2i
Počet	48 zaradených; 39 dokončilo liečbu
Demografia	Vek 48,9 (SD 13,9) roka; 58 % mužov
Kľúčový výsledok	UACR do 24. týždňa: LS mean −56 % (95 % IS −66 % až −3 %)

Metodický kontext: SPARTACUS nie je zaslepená randomizovaná komparatívna štúdia oproti pokračovaniu RASi. Pokles UACR preto silne podporuje hypotézu o prínose sparsentanu v prostredí SGLT2i, ale nedokazuje nadradenosť oproti „optimálne titrovanému RASi + SGLT2i“ v rovnakom dizajne. Sledovaným ukazovateľom bola albuminúria (UACR), nie UPCR ako v PROTECT OLE; pri citovaní treba tieto ukazovatele rozlišovať.

PROTECT OLE: pridanie SGLT2i k stabilnému sparsentanu

V substúdii otvoreného predĺženia PROTECT boli pacienti už liečení sparsentanom randomizovaní **1 : 1** na pridanie SGLT2i alebo pokračovanie samotným sparsentanom počas **12 týždňov**. Následne mohli všetci pokračovať v kombinácii sparsentan + SGLT2i ďalších až **24 týždňov**.

Do 12-týždňovej randomizovanej časti bolo zaradených **63** pacientov (všetci ju dokončili): sparsentan + SGLT2i **n = 32** (vek 51,4; SD 13,4; 81 % mužov) oproti samotnému sparsentanu **n = 31** (vek 50,6; SD 11,1; 68 % mužov). **24 týždňov** kombinácie dokončilo **54** pacientov.

V 12. týždni bol LS mean zmeny UPCR −11,1 % (95 % IS −26,3 % až 7,3 %) pri kombinácii oproti +17,7 % (95 % IS −2,4 % až 42,1 %) pri samotnom sparsentane. Relatívny pomer medzi skupinami bol **0,75** (95 % IS 0,58–0,98; $P < 0,05$).

Položka	Sparsentan + SGLT2i	Samotný sparsentan
Počet (12 týždňov)	32	31
Vek; podiel mužov	51,4 (13,4); 81 %	50,6 (11,1); 68 %
Zmena UPCR (LS mean, 12. týždeň)	−11,1 % (−26,3 % až 7,3 %)	+17,7 % (−2,4 % až 42,1 %)
Pomer medzi skupinami	0,75 (0,58–0,98); $P < 0,05$	
24 týždňov kombinácie	54 pacientov dokončilo	

V absolútnom vyjadrení ide o **mierny** ďalší pokles proteinúrie pri pridaní SGLT2i, nie o efekt veľkosti, aký sa pozoroval v SPARTACUS. Intervaly spoľahlivosti jednotlivých skupín zahŕňajú nulu, ale *kontrast medzi ramenami* dosiahol štatistickú významnosť. Pri interpretácii treba počítať s malým *n*, krátkym randomizovaným horizontom a tým, že neskôr mali všetci možnosť prejsť na kombináciu.

Bezpečnosť

Podľa abstraktu bolo málo nežiaducich udalostí súvisiacich s liečbou, ktoré by boli závažné, vážne alebo viedli k ukončeniu. Kombinácia bola hodnotená ako dobre tolerovaná, **bez neočakávaných bezpečnostných signálov**.

Aj tu platí opatrnosť: abstrakt neuvádza detailné frekvencie hyperkaliémie, poklesu eGFR, hepatotoxicity, retencie tekutín ani hypotenzie – teda oblasti, ktoré pri endotelínovej blokáde a SGLT2i treba v praxi sledovať. Krátke sledovanie nezachytí zriedkavé oneskorené riziká.

Čo výsledky podporujú a čo ešte nie

Oblasť	Podporujú	Nepodporujú / chýba
Albuminúria / proteinúria	Výrazný pokles UACR po výmene RASi→sparsentan pri SGLT2i; mierny ďalší pokles UPCR po pridaní SGLT2i k sparsentanu	Dôkaz o spomalení sklonu eGFR, dialýze, transplantácii alebo úmrtí
Sekvencia liečby	Oba praktické scenáre (výmena RASi; pridanie SGLT2i) majú empirickú oporu	Optimálne poradie voči imunoterapii podľa rizika progresie (KDIGO)
Bezpečnosť	Krátkodobá tolerancia bez neočakávaných signálov v abstrakte	Dlhodobý bezpečnostný profil kombinácie v bežnej praxi

Pre ambulantnú prax z toho vyplýva, že **kombinácia sparsentanu so SGLT2i pri IgAN je podľa týchto dát biologicky aj klinicky zmysluplnou cestou k ďalšiemu zníženiu proteinúrie**, najmä ak už pacient užíva jednu z týchto tried. Rozhodnutie však musí rešpektovať dostupnosť lieku, úhradu, kontraindikácie, monitorovanie a celkový rizikový profil pacienta – vrátane otázky, či je vhodnejšia cielená imunomodulácia.

Zhrnutie

SPARTACUS ukázal výrazný a udržaný pokles **UACR** po výmene RASi za sparsentan pri stabilnom SGLT2i. Substúdia PROTECT OLE ukázala, že pridanie SGLT2i k sparsentanu prináša oproti samotnému sparsentanu **relatívne priaznivejšiu zmenu UPCR** v 12. týždni (pomer 0,75). Kombinácia bola krátkodobo dobre tolerovaná. Ide o dôležité dôkazy na úrovni náhradného ukazovateľa (proteinúrie) v prospech kombinovanej nefroprotekcie pri IgAN, nie o definitívny dôkaz tvrdého klinického prínosu.

Súvisiace články na portáli

- Kompletná remisia proteinúrie v štúdii PROTECT (post hoc)
- Algoritmus manažmentu IgA nefropatie podľa KDIGO 2025
- IgA nefropatia: KDIGO 2025 a komentár KDOQI
- Telitacicept pri IgA nefropatii (TELIGAN)

Zdroj: *Isabelle Ayoub, Gabriela Alperovich, Radko Komers, Laura Ann Kooienga, Alex Mercer, Stephanie Moody, Ingrid Prkačin, Brad H. Rovin, Hira Siktel, Sydney C. W. Tang. Sparsentan – SGLT2 inhibitor combination therapy in trials of IgA nephropathy. Nephrol Dial Transplant. 2026 Sep 11:gfag211. doi:10.1093/ndt/gfag211. PubMed PMID 42726023; DOI; OUP (advance article).*

Ďalšie overené odkazy:

1. ClinicalTrials.gov: SPARTACUS (NCT05856760); PROTECT (NCT03762850).

Bibliografické údaje a dostupnosť odkazov overené 14. septembra 2026 (PubMed/eutils, Crossref, ClinicalTrials.gov). OUP stránka môže byť chránená Cloudflare výzvou; primárny overený prístup k abstraktu je cez PubMed. Text je odborným informačným materiálom a nenahrádza

individuálne klinické rozhodnutie.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=sparsentan-sglt2-inhibitor-iga-nefropatia-spartacus-protect · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.